



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PASURUAN
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN
SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS TELEMEDICINE DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN

=====

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor : 645.1/RSPHS/E-PKS/DIR/V/2025
.....

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-05-2025) bertempat di Pasuruan, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. dr. Dina Diana Permata, MM. AAK. selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Agung II Nomor 1 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 231/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS., selaku Direktur RS Prima Husada Sukorejo berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.100/DPM/I-KEP/DIR/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut,

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RS Prima Husada Sukorejo, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PIHAK** dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai penyelenggara pengembangan sistem pelayanan Kesehatan dan sistem pembayaran berbasis *Telemedicine* dalam Program Jaminan Kesehatan dan merupakan Penjamin Pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang Tenaga Kesehatan;
3. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan *Telemedicine* diperlukan kerjasama diantara **PARA PIHAK**;
4. Bahwa penyelenggaraan *Telemedicine* yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** merupakan pengembangan sistem pelayanan Kesehatan dan sistem pembayaran berbasis *Telemedicine* dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya secara bersama-sama **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Dan Sistem Pembayaran Berbasis *Telemedicine* Dalam Program Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat Perjanjian) dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Angka Kontak adalah jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP dibagi jumlah peserta terdaftar dengan target 150 per mill.
2. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
3. Apotek Program Rujuk Balik yang selanjutnya disingkat Apotek PRB adalah Apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan obat non kapitasi berdasarkan resep dari Dokter FKTP sesuai Surat Rujuk Balik kepada peserta Program Rujuk Balik.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
6. *Expertise* adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, *image* atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien.
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, tenaga kesehatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang tenaga kesehatan khusus.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberi Konsultasi adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi *Telemedicine*.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengirim permintaan konsultasi *Telemedicine*.
12. FKTP Uji Coba adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba *Telemedicine*.
13. FKTP Asal adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana uji coba *Telemedicine*, tetapi berada di lokasi berdekatan dengan FKTP Uji Coba sehingga memungkinkan dilakukan rujukan horizontal bagi Peserta Jaminan Kesehatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan *Telemedicine* oleh FKTP Uji Coba.

14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Jejaring Faskes adalah fasilitas kesehatan yang melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan aksesibilitas dan/atau menunjang pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**, antara lain laboratorium, apotek, bidan
16. Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Kesan (Kesan dan Pesan) adalah penilaian yang diberikan peserta terhadap pelayanan telekonsultasi yang diberikan dokter FKTP
18. Klaim adalah permintaan pembayaran atau tagihan atas ujrah pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**
19. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
20. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional SubjekData Pribadi
21. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
22. Peserta hamil dengan kondisi *Time, Age, Complication* dan *Comorbidity* (TACC) adalah ibu hamil yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria TACC pada Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
23. Peserta hamil dengan komorbid adalah ibu hamil dengan penyakit jantung, ginjal, *diabetes melitus*, malaria, HIV, sifilis, TBC, anemia berat, hipertensi, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, gangguan kejiwaan, atau penyakit lain yang menurut dokter dapat berisiko terhadap kehamilan saat ini.
24. Peserta Non PRB adalah peserta penderita penyakit kronis yang memiliki satu atau lebih kondisi dari sembilan diagnosis PRB (hipertensi, jantung, diabetes mellitus, asma, penyakit

- paru obstruktif kronis/PPOK, epilepsi, schizophrenia, stroke, Systemic Lupus Erythematosus/SLE) yang belum pernah mendapatkan pemeriksaan spesialisik.
25. Peserta PRB adalah Peserta penderita penyakit kronis dengan diagnosis hipertensi, jantung, *diabetes mellitus*, asma, penyakit paru obstruktif kronis/PPOK, *epilepsi*, *schizophrenia*, stroke, *Systemic Lupus Erythematosus/SLE*, dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan ketenaga kesehatan jangka panjang yang dilaksanakan di FKTP atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis.
 26. Peserta Potensi PRB adalah peserta penderita penyakit kronis yang memiliki satu atau lebih kondisi dari sembilan diagnosis PRB (hipertensi, jantung, diabetes mellitus, asma, penyakit paru obstruktif kronis/PPOK, epilepsi, schizophrenia, stroke, Systemic Lupus Erythematosus/SLE) yang pernah mendapatkan pemeriksaan spesialisik.
 27. Program Rujuk Balik yang selanjutnya disingkat PRB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan ketenaga kesehatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat.
 28. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi
 29. *Respon time* adalah lama waktu saat pasien menghubungi dokter sampai dengan pertama kali dokter merespon.
 30. *Respon Time* DPJP atau FKRTL adalah lama waktu saat dokter FKTP menghubungi dokter spesialis sampai dengan pertama kali dokter merespon dan memberikan rekomendasi tata laksana selanjutnya
 31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh dokumen/berkas pengajuan klaim telah dipastikan kebenarannya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat ketidaksesuaian, ketidakbenaran atau kelebihan pembayaran.
 32. *Time-Age-Complication-Comorbidity* yang selanjutnya disingkat TACC adalah kriteria yang digunakan oleh dokter dalam penentuan kondisi yang dapat dirujuk pada diagnosa yang termasuk tingkat kemampuan 4A dalam 144 diagnosa dengan kriteria Time, Age, Compication dan Comorbidity sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Tele-elektrokardiografi yang selanjutnya disingkat Tele-EKG adalah pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
34. Tele-ultrasonografi yang selanjutnya disingkat Tele-USG adalah pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
35. Telekonsultasi klinis adalah pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video dan harus terekam, tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Telekonsultasi non klinis adalah pemberian layanan non klinis dalam bentuk konsultasi kesehatan jarak jauh yang mencakup antara lain jasa kesehatan, edukasi kesehatan, dan administrasi kesehatan. Telekonsultasi non klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video dan harus terekam, tercatat dalam riwayat pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
37. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
38. Verifikasi klaim adalah proses pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen sebagai syarat dalam pembayaran klaim

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pelayanan Kesehatan dan sistem pembayaran berbasis *Telemedicine* dalam Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya kerjasama produktif antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada Peserta melalui pengembangan sistem pelayanan Kesehatan dan sistem pembayaran berbasis *Telemedicine* dalam Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini yaitu pelayanan *telemedicine* Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL meliputi:
 1. Telekonsultasi yang dilakukan berupa telekonsultasi klinis;
 2. Telekonsultasi oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL Penerima Rujukan *Telemedicine* pada Peserta PRB, Potensi PRB, dan kehamilan TACC yang dilakukan pemeriksaan fisik di FKTP dan dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL untuk penetapan diagnosa maupun terapinya;
 3. Tele-EKG oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL terhadap Peserta PRB khususnya pada penyakit hipertensi dan Jantung serta Peserta dengan potensi PRB yang dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL dengan melakukan pemeriksaan EKG di FKTP untuk penetapan diagnosis maupun terapinya;
 4. Tele-USG oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL diberikan terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan (*ante natal care* (ANC)) dengan TACC dan/atau setelah persalinan (*post natal care* (PNC)) dengan TACC, yang dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL dengan melakukan pemeriksaan USG di FKTP untuk penetapan diagnosa maupun terapinya
- (2) Uraian ruang lingkup dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menentukan besaran tarif uji coba pelayanan telemedicine dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang SDM Klinis, jadwal pelayanan, sarana prasarana, data rekening pembayaran **PIHAK KEDUA** serta informasi lain tentang pelayanan telemedicine melalui aplikasi milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima nama-nama dokter spesialis sesuai ketentuan selama uji coba dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi yang terlibat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan *Telemedicine* melalui Keputusan Kepala/Pimpinan Fasilitas Kesehatan dan menyampaikan ke **PIHAK KESATU**
- d. Menerima berkas tagihan klaim pelayanan telemedicine berupa *softcopy pdf atau* salinan cetak setiap bulan secara lengkap, valid, akurat dan benar;
- e. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan meliputi perubahan nomor rekening, nama bank, nama rekening, dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara tertulis dan melalui sistem pada aplikasi HFIS;
- g. Melakukan audit terhadap klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Auditor **PIHAK KESATU** dan/atau PIHAK lain.
- h. Menerima pengembalian dari **PIHAK KEDUA** atau melakukan pemotongan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- i. Melakukan monitoring evaluasi atas capaian indikator pelayanan *telemedicine* yang diberikan kepada peserta;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan, pembayaran dan pelaksanaan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. Menyediakan aplikasi terkait sistem informasi pelayanan kesehatan *telemedicine* dan memberikan hak akses aplikasi yang akan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pelayanan Peserta JKN dan pengajuan klaim;
- c. Melakukan pembayaran klaim *telemedicine* kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas Klaim dinyatakan lengkap, dalam hal pembayaran klaim jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- d. Membayar kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- e. Menyampaikan hasil evaluasi pelayanan *telemedicine* selama perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan *telemedicine*, penggunaan aplikasi, pembayaran dan pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima pembayaran klaim atas pelayanan *telemedicine* yang diberikan kepada Peserta sejak berkas klaim diajukan dan telah diverifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KESATU**
- c. Mendapatkan sistem informasi pelayanan dan pengajuan klaim *telemedicine* Peserta dan daftar FKRTL dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima hasil evaluasi pelayanan *telemedicine* selama perjanjian kerjasama **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**;
- e. Menerima kekurangan pembayaran dari **PIHAK KESATU** dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap **PIHAK KESATU** termasuk hasil verifikasi pasca klaim dan/atau audit administrasi klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan pelayanan *telemedicine* kepada Peserta JKN sebagaimana diatur dalam Lampiran I serta sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan, tidak meminta biaya tambahan kepada peserta;

- b. Memberikan pelayanan kesehatan *telemedicine* dengan merespon permintaan konsultasi dari Dokter FKTP melalui sistem informasi **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup, jadwal praktik dan prosedur layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I pada Perjanjian ini tanpa meminta biaya tambahan kepada FKTP dan Peserta;
- c. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi yang terlibat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Kepala/Pimpinan Fasilitas Kesehatan dan menyampaikan ke **PIHAK KESATU**. Nama-nama dokter yang berkomitmen tercantum dalam Lampiran III;
- d. Menggunakan aplikasi sistem informasi pelayanan telemedicine milik **PIHAK KESATU** untuk kepentingan proses pelayanan dan pengajuan klaim telemedicine ;
- e. Memberikan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia, sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Mengajukan berkas tagihan Klaim non kapitasi setiap bulan dan lengkap kepada **PIHAK KESATU** berupa *softcopy pdf atau* salinan cetak setiap bulan secara lengkap, valid, akurat dan benar;
- g. Menyediakan bukti pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang bukti yang diminta berhubungan dengan kasus yang di audit;
- h. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan meliputi perubahan nomor rekening, nama bank, nama rekening, dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara tertulis dan melalui sistem pada aplikasi HFIS

PASAL 5

KADALUARSA KLAIM PELAYANAN *TELEMEDICINE*

- (1) Kadaluarasa klaim kolektif telemedicine yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan dan berkas klaim diterima lengkap oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali;

PASAL 6
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan, selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini dan Addendumnya (jika ada), tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya baik *hardcopy* maupun *softcopy*, tertulis ataupun lisan yang diterima oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung, selama pelaksanaan Perjanjian ini dan Addendumnya (jika ada).
- (2) Pengetahuan dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Informasi mengenai pasien
 - b. Informasi mengenai alasan penolakan klaim
 - c. Informasi mengenai rincian klaim
 - d. Informasi rahasia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** termasuk pegawai dan afiliasi/jejaringnya termasuk pihak lain yang bekerja sama dengan **PARA PIHAK** diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawai dan afiliasi/jejaringnya termasuk pihak lain yang bekerja sama dengan **PARA PIHAK** melakukan hal tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum/perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

- c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Kesehatan secara keseluruhan.

PASAL 7

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** memiliki kedudukan yang sama sebagai Pengendali Data Pribadi yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pelindungan Data Pribadi, antara lain:
 - a. Memiliki ketentuan dan pedoman terkait implementasi Pelindungan Data Pribadi yang paling sedikit mengatur tentang tujuan, mekanisme pengumpulan data, pemanfaatan data, penyimpanan data, dan penghapusan/pemusnahan data.
 - b. Menerapkan standar dan Sistem Keamanan Data dan Informasi.
 - c. Menunjuk dan melaksanakan tugas Pejabat Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan Pihak lain sebagai Prosesor Data Pribadi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, maka wajib dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KEDUA** membuat kontrak kerja dengan Prosesor Data Pribadi yang memuat ketentuan Pelindungan Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan, *assessment* dan/atau memberikan rekomendasi terhadap sistem keamanan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, salah satu **PIHAK** menemukan adanya celah keamanan pada sistem **PIHAK** lain dan atau salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka **PIHAK** lainnya dapat menanggukuhkan transfer Data Pribadi hingga

permasalahan diselesaikan dan ketentuan dipatuhi kembali yang dibuktikan dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh **PIHAK** lainnya. Penangguhan tersebut tidak berdampak kepada penjaminan layanan peserta JKN.

- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** dimaksud bertanggung jawab penuh terhadap seluruh konsekuensi yang terjadi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Lampiran IV Perjanjian ini.

PASAL 8

KEAMANAN DAN INTEGRASI SISTEM

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan akun sistem informasi kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal **PARA PIHAK** telah melaksanakan integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 huruf s, **PIHAK KESATU** memberikan izin penggunaan akun sistem informasi, *consID*, *userKey* dan *secretKey* dalam bentuk file terenkripsi kepada **PIHAK KEDUA** melalui media surat elektronik (email);
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** telah melaksanakan integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** memastikan penggunaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* sesuai dengan kebutuhan integrasi sistem yang tercantum pada Pakta Integritas pengun *consID* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada Lampiran V;
- (3) Dalam hal pengembangan sistem informasi milik **PIHAK KEDUA** yang diintegrasikan dengan sistem milik **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan pihak lain;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pemutusan kerja sama pengembangan sistem informasi dengan pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum terjadi perubahan atau pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan izin penggunaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* baru;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab memastikan keamanan dan kerahasiaan akun user, *consID*, *userKey* dan *secretKey* selama masa kontrak maupun setelah kontrak berakhir termasuk dalam hal **PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan pihak lain dalam pengembangan SIM-Faskes yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi milik **PIHAK KESATU**;

- (6) Pelaksanaan integrasi Aplikasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan terjadinya pertukaran data **PARA PIHAK**, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan sepakat untuk menjaga keamanan data.
- (7) Adapun yang dimaksud dengan keamanan data sebagaimana ayat (1) diatas adalah perlindungan data dan informasi pribadi peserta JKN yang menjadi pasien di FKTP dan data Sumber Daya Manusia pada **PIHAK KEDUA** yang memberikan layanan kepada peserta JKN.
- (8) Apabila terdapat pelanggaran/ penyalahgunaan/ peminjaman/ pemberian/ pemberitahuan akun sistem informasi, *consID*, *userKey*, dan *secretKey* oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, maka :
- a. **PIHAK KESATU** berhak menonaktifkan dan mengganti akun user, *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana komitmen terhadap keamanan data terkait dengan integrasi sistem dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan keamanan dan kerahasiaan akun user, *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Dalam hal terjadi pelanggaran maksimal 3 kali oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** dapat menolak pengajuan user atau menghentikan integrasi sistem dengan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menyebabkan kerugian financial/berdampak negatif pada reputasi **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk melaporkan **PIHAK KEDUA** kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 9

JASA PELAYANAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya jasa pelayanan dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini diuraikan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2026;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir jangka waktu kesepakatan bersama ini.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi pelayanan secara periodik maksimal per triwulan atas penyelenggaraan pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan berbasis *Telemedicine* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan);
- (3) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, **PIHAK KESATU** secara langsung dan/atau dengan Perjanjian melibatkan organisasi profesi, dinas kesehatan, berhak untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Evaluasi pengembangan yang dilakukan meliputi indikator respon time, kemampuan tuntas pelayanan, Kesan (Kesan dan pesan, potensi PRB, pasien PRB, potensi PRB menjadi PRB);
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, **PIHAK KEDUA** juga wajib untuk menyediakan bukti pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang bukti yang diminta berhubungan dengan kasus yang di audit;

PASAL 12

SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta sesuai dengan isi perjanjian ini;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta melalui permintaan layanan dari Dokter FKTP sesuai dengan ketentuan;

- c. Menarik biaya pelayanan kesehatan kepada FKTP dan Peserta selama pelayanan telemedicine sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian ini namun tidak terbatas pada pasal 6 ayat (4).

Maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran lisan, teguran lisan tertulis, surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu pengenaan untuk teguran tertulis berikutnya paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya.
- (3) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun **PIHAK KEDUA** tidak ada perbaikan dan/atau terdapat keluhan berulang dari Peserta, maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian.
- (4) Ketentuan waktu pengenaan untuk teguran tertulis paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan terhadap tindakan tersebut dapat langsung dikenakan teguran tertulis.
- (5) Teguran Tertulis yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Dinas Kesehatan dan Asosiasi FKTP setempat.
- (6) Dalam hal tindakan Kecurangan JKN dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, maka diberlakukan sanksi administrasi, sanksi tambahan berupa denda dan/atau pengakhiran Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan tindakan kecurangan (fraud), maka **PIHAK KESATU** memberikan sanksi berupa pengakhiran Perjanjian dan dapat bekerja sama kembali dalam jangka waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA **PIHAK**;

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah menerima surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3);
- (2) **PIHAK KEDUA** sudah tidak memenuhi persyaratan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal Surat Izin Praktik **PIHAK KEDUA** yang telah habis masa berlakunya atau dicabut oleh Pemerintah maka Perjanjian ini berakhir pada tanggal terakhir bulan sebelum SIP Dokter habis dan dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah memiliki SIP Dokter Spesialis Perjanjian ini berakhir sesuai dengan tanggal terbit SIP Dokter Spesialis.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bekerja sama lagi dengan **PIHAK KESATU** sebelum masa kerjasama berakhir sebagaimana diatur dalam ayat (2) pada Pasal ini, maka pemindahan Peserta yang terdaftar di **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi sengketa diantara **PARA PIHAK** berkaitan dengan Perjanjian ini, dimana salah satu **PIHAK** menerima relaas gugatan perdata, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir pada tanggal terakhir bulan saat relaas gugatan tersebut diterima. Terkait dengan terjadinya pemindahan Peserta menjadi kewenangan dari **PIHAK KESATU**.
- (6) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.

- (7) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa), wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU: BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan

Jl. Sultan Agung II Nomor 1

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Up. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan

PIC : Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan

No. Telpn : 0343 - 427454

Email : kc-pasuruan@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA: RS Prima Husada Sukorejo

Jalan Raya Surabaya – Malang KM 54

Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Up. : Direktur RS Prima Husada Sukorejo

No. Telpn : 0343-6745000

Email : info.sukorejo@rs-primahusada.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan secara tertulis dianggap telah diterima oleh para PIHAK apabila:
- a. Diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
 - b. Dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut;

- c. Melalui faksimili dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi; dan/atau
- d. Melalui *email* dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

PASAL 17

LAIN-LAIN

(1) Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.

(2) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

(3) Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Batasan Tanggung Jawab

PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

(5) Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

(6) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan/atau dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Cabang
Pasuruan



Dina Diana Permata

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

A blue circular logo for 'RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA' is overlaid with a black ink signature.

dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS.

Lampiran I Perjanjian

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor :

**RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
PELAYANAN KESEHATAN**

A. RUANG LINGKUP

- a. Ruang lingkup layanan Telemedicine Dokter FKTP ke Dokter ke FKRTL yang dikembangkan:
 - 1) Telekonsultasi yang dilakukan berupa telekonsultasi klinis;
 - 2) Dokter FKRTL menerima permintaan konsultasi dari Dokter FKTP baik berupa telekonsultasi dan *teleexpertise* ;
 - 3) Telekonsultasi oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL Penerima Rujukan Telemedicine pada :
 - a) Peserta PRB yang memiliki riwayat penyakit *Diabetes Mellitus*, Hipertensi, Jantung, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) pada bulan ke-4;
 - b) Peserta PRB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menerima pelayanan sebelum bulan ke – 4 apabila terdapat kondisi medis yang membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis maka dokter FKTP mencatat kondisi medis pasien dan memastikan kondisi pasien memenuhi kriteria TACC sesuai dengan Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - c) Peserta Potensi PRB yang memenuhi kriteria medis menjadi PRB ; atau
 - d) Peserta dengan kehamilan TACC yang dilakukan pemeriksaan fisik di FKTP dan dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL untuk penetapan diagnosa maupun terapinya.
 - 4) Tele-EKG
 - a) Tele-EKG oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL terhadap Peserta PRB khususnya pada penyakit hipertensi dan Jantung serta Peserta dengan potensi PRB yang dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL dengan melakukan pemeriksaan EKG di FKTP untuk penetapan diagnosis maupun terapinya.
 - b) Tele-EKG dilakukan pada bulan ke- 4 terhadap Peserta PRB atau Peserta potensi PRB yang memenuhi kriteria medis untuk menjadi Peserta PRB. Apabila diperlukan, Tele-

EKG dapat dilakukan apabila kondisi medis membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis. Dokter FKTP mencatat kondisi medis pasien pada rekam medis atau sistem informasi yang ada dan memastikan kondisi pasien memenuhi kriteria TACC sesuai dengan Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

5) Tele- USG

- a) Tele-USG oleh Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL diberikan terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan (*ante natal care* (ANC)) dengan TACC dan/atau setelah persalinan (*post natal care* (PNC)) dengan TACC, yang dimungkinkan tidak dilakukan rujukan fisik ke FKRTL dengan melakukan pemeriksaan USG di FKTP untuk penetapan diagnosa maupun terapinya.
 - b) Tele-USG dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan hasil *assessment* dokter yang memeriksa. Tele-USG didokumentasikan pada rekam medis dan sistem informasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.
 - c) Apabila Tele-USG dilakukan pada pemeriksaan kehamilan (*ante natal care* (ANC)) pertama (trimester I) dan kelima.
 - d) Pelayanan Tele-EKG dan Tele-USG dilakukan berdasarkan literasi kompetensi Dokter FKTP dan Dokter FKRTL yang berlaku.
- b. Pembiayaan pelayanan Telekonsultasi dan *Teleexpertise* berupa non kapitasi dengan tarif uji coba.

B. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS TELEMEDICINE

1. Tata cara Pelaksanaan Pelayanan Telekonsultasi Dokter FKTP ke Dokter FKRTL pada kasus PRB dan Potensi PRB

a. Pasien PRB

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan telah termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Wilayah Uji Coba.
- (2) Peserta PRB (*Diabetes Mellitus*, Hipertensi, Jantung, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)) datang ke FKTP terdaftar.
- (3) Kunjungan Peserta PRB adalah pada bulan ke-4 (empat), dan seterusnya dari kunjungan terakhir peserta PRB berkunjung ke FKRTL atau mendapatkan pelayanan Telemedicine saat peserta PRB dianjurkan kontrol dengan Spesialis di FKRTL.

- (4) Dokter FKTP melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada Peserta PRB dan melakukan asesmen medis, antara lain :
- (a) Jika pasien PRB dalam kondisi stabil maka obat diteruskan sebagaimana peresepan obat sebelumnya;
 - (b) Jika kondisi pasien PRB membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis maka Dokter FKTP dapat menyiapkan pasien untuk dilakukan telekonsultasi sesuai langkah sebagai berikut :
 - ✓ Dokter FKTP mencatat kondisi pasien di rekam medis yang tersedia di FKTP.
 - ✓ Dokter/ Tenaga Kesehatan di FKTP memilih jenis pelayanan telekonsultasi pada Aplikasi Pcare.
 - ✓ Dokter/ Tenaga Kesehatan di FKTP menginput kondisi pasien pada aplikasi pcare layanan *telemedicine*.
 - ✓ Dokter/ Tenaga Kesehatan di FKTP memilih FKRTL pertama penerima rujukan (FKRTL-1).
 - ✓ Dokter FKTP menunggu respon FKRTL-1 maksimal 15 (lima belas) menit.
 - ✓ Apabila setelah 15 (lima belas) menit tidak ada respon dari FKRTL-1, maka permintaan telekonsultasi akan diteruskan pada FKRTL kedua penerima rujukan (FKRTL-2).
 - ✓ Dokter Spesialis memberikan tanggapan sesuai permintaan telekonsultasi melalui aplikasi vclaim atau aplikasi mobile JKN Faskes yang disediakan PIHAK KESATU.
 - ✓ Dokter/ Tenaga Kesehatan FKTP menerima analisis dan rekomendasi Dokter Spesialis dapat berupa :
 - (1) Pasien PRB dapat dilanjutkan pemberian obat dari FKTP melalui Apotek PRB, sesuai Surat Rujuk Balik (SRB) dan atau tanpa penyesuaian dosis.
 - (2) Pasien PRB harus dirujuk fisik ke FKRTL karena memerlukan pemeriksaan penunjang lain yang tidak tersedia di FKTP; pasien dirujuk mengikuti alur pelayanan rujukan yang berlaku.
- (5) Peserta PRB yang melanjutkan pengobatan PRB di FKTP mendapatkan obat PRB sesuai alur pelayanan obat yang berlaku.
- b) Pasien Potensi PRB
- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan telah termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Wilayah Uji Coba.

- (2) Peserta Potensi PRB (Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Penyakit Paru Obstruktif Kronis /PPOK, Stroke, Systemic Lupus Erythematosus/SLE) datang ke FKTP terdaftar.
- (3) Identifikasi Potensi PRB terdapat pada flagging aplikasi p-care atau sistim informasi di FKRTL atau data base peserta potensi PRB aplikasi PIHAK KESATU.
- (4) Dokter FKTP melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada Peserta Potensi PRB dan melakukan asesmen medis, antara lain:
 - (a) Jika kondisi pasien Potensi PRB belum dalam kondisi stabil maka Dokter FKTP akan merujuk Pasien ke FKRTL sesuai ketentuan dan alur pelayanan yang berlaku;
 - (b) Jika kondisi pasien Potensi PRB dalam kondisi stabil dan jenis obat yang selama ini diperoleh di FKRTL termasuk obat PRB sehingga dapat dilanjutkan pengobatan di FKTP maka Dokter FKTP dapat menyiapkan pasien untuk dilakukan telekonsultasi Potensi PRB menjadi PRB sesuai langkah sebagai berikut:
 - ✓ Dokter FKTP mencatat kondisi pasien di rekam medis yang tersedia di FKTP.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih jenis pelayanan telekonsultasi pada Aplikasi Pcare.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP menginput kondisi pasien pada aplikasi pcare layanan telemedicine.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih FKRTL pertama penerima rujukan (FKRTL-1).
 - ✓ Dokter FKTP menunggu respon FKRTL-1 maksimal 15 (lima belas) menit.
 - ✓ Apabila setelah 15 (lima belas) menit tidak ada respon dari FKRTL-1, maka permintaan telekonsultasi akan diteruskan pada FKRTL kedua penerima rujukan (FKRTL-2).
 - ✓ Dokter Spesialis memberikan tanggapan sesuai permintaan telekonsultasi melalui aplikasi vclaim atau aplikasi mobile JKN Faskes yang disediakan PIHAK KESATU.
 - ✓ Dokter Spesialis melakukan flagging PRB, mengisi SRB PRB dan mengisi obat PRB.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan FKTP menerima analisis dan rekomendasi Dokter Spesialis berupa SRB PRB yang berisikan diagnosa pasien, catatan medis

apabila dirasa perlu oleh spesialis, dan peresepan obat utama dan obat tambahan.

- ✓ Dokter FKTP/Tenaga Kesehatan FKTP mengisikan jenis obat utama pada aplikasi Pcare-PRB MTM.
 - ✓ Apotek PRB menerima informasi obat PRB yang diinput FKTP.
 - ✓ Apotek PRB menyiapkan obat PRB sesuai peresepan.
 - ✓ Pasien bisa memperoleh obat PRB di Apotek/Ruang Farmasi/Instalasi Farmasi FKTP atau melalui proses penghantaran obat ke Alamat pasien/FKTP.
 - ✓ Apabila di wilayah ujicoba belum memiliki Apotek PRB karena keterbatasan geografis maka dioptimalkan melalui obat yang tersedia di Apotek/Ruang Farmasi/Instalasi Farmasi FKTP.
- (5) Setelah Dokter FKRTL membuat SRB PRB melalui aplikasi Vclaim *telemedicine* maka peserta telah terflagging PRB dan selanjutnya mengikuti pelayanan *telemedicine* dan atau pelayanan kesehatan JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tata cara Pelaksanaan Pelayanan Tele EKG Dokter FKTP ke Dokter FKRTL pada kasus PRB dan Potensi PRB

a. Pasien PRB

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan telah termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Wilayah Uji Coba.
- (2) Peserta PRB (Hipertensi, Jantung) datang ke FKTP terdaftar.
- (3) Kunjungan Peserta PRB adalah pada bulan ke-4 (empat), dan seterusnya dari kunjungan terakhir peserta PRB berkunjung ke FKRTL atau mendapatkan pelayanan *Telemedicine* saat peserta PRB dianjurkan kontrol dengan Spesialis di FKRTL.
- (4) Dokter FKTP melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada Peserta PRB dan melakukan asesmen medis, antara lain:
 - (c) Jika pasien PRB dalam kondisi stabil maka obat diteruskan sebagaimana peresepan obat sebelumnya;
 - (d) Apabila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang maka dokter melakukan elektrokardiogram (EKG);

(e) Apabila hasil pemeriksaan EKG membutuhkan pelayanan *Telemedicine*, maka Dokter FKTP dapat menyiapkan pasien untuk dilakukan telekonsultasi sesuai langkah sebagai berikut:

- ✓ Dokter FKTP mencatat kondisi pasien di rekam medis yang tersedia di FKTP.
- ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih jenis pelayanan EKG pada Aplikasi Pcare.
- ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP menginput kondisi pasien pada aplikasi pcare layanan telemedicine.
- ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP mengupload luaran pemeriksaan EKG.
- ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih FKRTL pertama penerima rujukan (FKRTL-1).
- ✓ Dokter FKTP menunggu respon FKRTL-1 maksimal 15 (lima belas) menit.
- ✓ Apabila setelah 15 (lima belas) menit tidak ada respon dari FKRTL-1, maka permintaan telekonsultasi akan diteruskan pada FKRTL kedua penerima rujukan (FKRTL-2).
- ✓ Dokter Spesialis memberikan tanggapan sesuai permintaan melalui aplikasi vclaim atau aplikasi mobile JKN Faskes yang disediakan PIHAK KESATU.
- ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan FKTP menerima analisis dan rekomendasi Dokter Spesialis dapat berupa:
 - (1) Pasien PRB dapat dilanjutkan pemberian obat dari FKTP melalui Apotek PRB, sesuai SRB dan atau tanpa penyesuaian dosis.
 - (2) Pasien PRB harus dirujuk fisik ke FKRTL karena memerlukan pemeriksaan penunjang lain yang tidak tersedia di FKTP; pasien dirujuk mengikuti alur pelayanan rujukan yang berlaku.
 - (3) Peserta PRB yang melanjutkan pengobatan PRB di FKTP mendapatkan obat PRB sesuai alur pelayanan obat yang berlaku.

b. Pasien Potensi PRB

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Wilayah Uji Coba.
- (2) Peserta Potensi PRB (Hipertensi, Jantung, Stroke) datang ke FKTP terdaftar.
- (3) Identifikasi Potensi PRB terdapat pada flagging aplikasi p-care atau sistem informasi di FKRTL atau data base peserta potensi PRB aplikasi PIHAK KESATU.

- (4) Dokter FKTP melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan EKG kepada Peserta Potensi PRB dan melakukan asesmen medis, antara lain :
- (a) Jika kondisi pasien Potensi PRB belum dalam kondisi stabil maka Dokter FKTP akan merujuk Pasien ke FKRTL sesuai ketentuan dan alur pelayanan yang berlaku;
 - (b) Apabila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang maka dokter melakukan elektrokardiogram (EKG);
 - (c) Jika kondisi medis pasien Potensi PRB dapat dilanjutkan pengobatan di FKTP dan jenis obat yang selama ini diperoleh di FKRTL termasuk obat PRB maka Dokter FKTP dapat menyiapkan pasien untuk dilakukan pelayanan telemedisin Potensi PRB menjadi PRB sesuai langkah sebagai berikut:
 - ✓ Dokter FKTP mencatat kondisi pasien di rekam medis yang tersedia di FKTP.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih jenis pelayanan tele-EKG pada Aplikasi Pcare.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP menginput kondisi pasien pada aplikasi pcare layanan *telemedicine*.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP mengupload luaran pemeriksaan EKG.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan di FKTP memilih FKRTL pertama penerima rujukan (FKRTL-1).
 - ✓ Dokter FKTP menunggu respon FKRTL-1 maksimal 15 (lima belas) menit.
 - ✓ Apabila setelah 15 (lima belas) menit tidak ada respon dari FKRTL-1, maka permintaan telekonsultasi akan diteruskan pada FKRTL kedua penerima rujukan (FKRTL-2).
 - ✓ Dokter Spesialis memberikan tanggapan sesuai permintaan telekonsultasi melalui aplikasi vclaim atau aplikasi mobile JKN Faskes yang disediakan PIHAK KESATU.
 - ✓ Dokter Spesialis melakukan flagging PRB, mengisi SRB PRB dan mengisi obat PRB.
 - ✓ Dokter/Tenaga Kesehatan FKTP menerima analisis dan rekomendasi Dokter Spesialis berupa SRB PRB yang berisikan diagnosa pasien, catatan medis apabila dirasa perlu oleh spesialis, dan peresepan obat utama dan obat tambahan.

- ✓ Dokter FKTP/Tenaga Kesehatan FKTP mengisikan jenis obat utama pada aplikasi Pcare-PRB MTM.
 - ✓ Apotek PRB menerima informasi obat PRB yang diinput FKTP.
 - ✓ Apotek PRB menyiapkan obat PRB sesuai peresepan.
 - ✓ Pasien bisa mendapatkan obat PRB melalui proses penghantaran obat ke Alamat pasien/FKTP, pasien/keluarga pasien menjemput ke Apotek PRB dan obat diambil pada IF Puskesmas.
 - ✓ Apabila di wilayah ujicoba belum memiliki Apotek PRB karena keterbatasan geografis maka dioptimalkan melalui obat yang tersedia di IF FKTP.
- (5) Setelah Dokter FKRTL membuat SRB PRB melalui aplikasi Vclaim *telemedicine* maka peserta telah terflagging PRB dan selanjutnya mengikuti pelayanan tatap muka dan atau non tatap muka (*telemedicine*) yang berlaku di Wilayah Uji Coba.
- (6) Untuk kepastian obat yang dimiliki oleh pasien PRB maka FKTP harus memastikan ketersediaan obat yang dimiliki pasien Potensi PRB saat berobat di FKRTL sebelumnya.

3. Tata cara Pelaksanaan Pelayanan Telekonsultasi atau Tele-USG Dokter FKTP ke Dokter FKRTL pada kasus kehamilan (ANC) atau Setelah Persalinan (PNC)

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan telah termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Wilayah Uji Coba.
- (2) Pasien hamil atau pasien dalam masa sesudah melahirkan (PNC) datang ke FKTP terdaftar.
- (3) Dokter FKTP melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terhadap kondisi kehamilan peserta dan melakukan asesmen kondisi medis pasien sebagai berikut:
- (a) kondisi medis pasien tuntas di FKTP sehingga tidak membutuhkan telekonsultasi dengan Dokter Spesialis.
 - (b) kondisi medis pasien membutuhkan telekonsultasi dengan/tanpa pemeriksaan penunjang dengan Dokter Spesialis atau kondisi memenuhi kriteria TACC sesuai dengan Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, maka pelayanan pasien sebagai berikut :
 - Dokter FKTP mencatat kondisi pasien di rekam medis yang tersedia di FKTP.
 - Dokter/Bidan di FKTP memilih jenis pelayanan telekonsultasi atau layanan tele-USG apabila dokter melakukan pemeriksaan USG pada Aplikasi Pcare.

- Dokter/Bidan di FKTP menginput kondisi pasien pada aplikasi pcare layanan telemedicine.
 - Dokter/Bidan di FKTP mengupload luaran pemeriksaan USG.
 - Dokter/Bidan di FKTP memilih FKRTL pertama penerima rujukan (FKRTL-1).
 - Dokter FKTP menunggu respon FKRTL-1 maksimal 15 (lima belas) menit.
 - Apabila setelah 15 (lima belas) menit tidak ada respon dari FKRTL-1, maka permintaan telekonsultasi akan diteruskan pada FKRTL kedua penerima rujukan (FKRTL-2).
 - Dokter Spesialis memberikan tanggapan sesuai permintaan melalui aplikasi vclaim atau aplikasi mobile JKN Faskes yang disediakan PIHAK KESATU.
 - Jika kondisi kehamilan tidak membutuhkan rujukan fisik ke FKRTL, maka pasien akan mendapatkan pengobatan di FKTP sesuai rekomendasi dokter spesialis.
 - Jika kondisi kehamilan membutuhkan rujukan fisik ke FKRTL, maka pasien dirujuk sesuai dengan alur pelayanan yang berlaku.
 - Pemeriksaan penunjang USG dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi medis kehamilan pasien.
- (4) Pemberian obat pasien hamil yang mendapatkan layanan telemedicine sesuai dengan alur pelayanan obat di wilayah uji coba.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Cabang
Pasuruan



Dina Diana Permata

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS.

Lampiran II Perjanjian

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor :

BIAYA DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN *TELEMEDICINE*

A. BIAYA PELAYANAN *TELEMEDICINE*

- a. Pembiayaan pelayanan *Telemedicine* Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL berupa Non Kapitasi.
- b. Tarif Pelayanan Telekonsultasi Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL untuk pasien tidak dirujuk, sebagai berikut:

Tarif Pelayanan Telemedisin FKTP ke FKRTL (Pasien Tidak Dirujuk)	PUSKESMAS			KLINIK PRATAMA		
	TOTAL TARIF	FKTP	FKRTL	TOTAL TARIF	FKTP	FKRTL
Telekonsultasi Klinis	95.000	15.000	80.000	95.000	15.000	80.000
Tele EKG	90.000	35.000	55.000	100.000	45.000	55.000
Tele USG	90.000	35.000	55.000	100.000	45.000	55.000

- c. Pelayanan Telekonsultasi Dokter FKTP kepada Dokter Spesialis di FKRTL untuk pasien dirujuk, sebagai berikut:

Tarif Pelayanan Telemedisin FKTP ke FKRTL (Pasien Dirujuk)	PUSKESMAS			KLINIK PRATAMA		
	TOTAL TARIF	FKTP	FKRTL	TOTAL TARIF	FKTP	FKRTL
Telekonsultasi Klinis	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
Tele EKG	75.000	35.000	40.000	85.000	45.000	40.000
Tele USG	75.000	35.000	40.000	85.000	45.000	40.000

- d. Pelayanan Tele-EKG dan Tele-USG dilakukan berdasarkan literasi kompetensi Dokter FKTP dan Dokter FKRTL yang berlaku.
- e. Pembiayaan Tele-EKG untuk Peserta PRB serta Peserta Potensi PRB Hipertensi, Jantung dan Stroke pada bulan keempat atau masa berlaku rujukan 90 (sembilan puluh) hari telah habis. Pembiayaan juga dapat dilakukan pada saat pasien memiliki kebutuhan khusus saat kondisi memenuhi kriteria TACC sesuai dengan Panduan

Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Dokter FKTP harus melengkapi *evidence assessment* medis dan menuliskan di riwayat pelayanan.

- f. Pembayaran Tele-EKG telah mencakup biaya dukungan alat penunjang tindakan EKG di FKTP, pembacaan *expertise* EKG, dan pembiayaan Telekonsultasi Klinis.
- g. Pembiayaan pelayanan telemedicine tidak dilakukan apabila Dokter FKRTL tidak merespon sebelum atau sama dengan 15 (lima menit) sejak permintaan Dokter FKTP diterima.
- h. Pemeriksaan USG skrining obstetri dilakukan oleh dokter FKTP dengan kompetensi:
 - a) lulusan 2012 ke atas sebagai bagian dari kompetensi 4A dokter umum sesuai SKDI 2012; atau
 - b) lulusan sebelum 2012 diperoleh dari pendidikan, pelatihan, workshop, atau orientasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, organisasi profesi, balai pelatihan kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- i. Apabila Tele-USG dilakukan pada pemeriksaan kehamilan (*ante natal care* (ANC)) pertama (trimester I) dan kelima (trimester III) maka pembiayaan tele-USG di FKTP tidak dapat ditagihkan.

B. TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

- 1. Pengajuan klaim diajukan secara kolektif oleh FKRTL secara periodik dan lengkap setiap bulan.
- 2. Kelengkapan Pengajuan Klaim FKRTL Penerima Rujukan Telekonsultasi
 - a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:
 - 1) Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan FKRTL atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
 - 2) Kuitansi asli bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan FKRTL atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
 - b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:
 - 1) bukti pendukung pelayanan; dan
 - 2) kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam masing-masing tagihan klaim.

4. Pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada FKRTL mengikuti ketentuan yang berlaku pada pengajuan dan pembayaran klaim secara non kapitasi
5. Kadaluaarsa klaim kolektif yang diajukan yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelayanan kesehatan diberikan.
6. BPJS Kesehatan Kantor Cabang membayarkan sesuai tarif pelayanan selama masa pengembangan kepada FKRTL uji coba yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan.
7. Dalam hal pembayaran mengakibatkan biaya transfer karena perbedaan bank, biaya menjadi tanggungan penerima pembayaran.
8. Untuk menjaga akuntabilitas pembayaran jaminan pelayanan kesehatan selama masa pengembangan, maka setiap pihak berkomitmen untuk mencegah potensi kecurangan. Apabila ditemukan indikasi kecurangan, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Rekening pelayanan telemedisin JKN disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada

PIHAK KESATU;

Rekening Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1440055533324
No. NPWP : 21.137.072.1-624.001 a.n RS Prima Husada Sukorejo

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Cabang
Pasuruan



Dina Diana Permata

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS.

Lampiran III Perjanjian

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor :

**NAMA DOKTER SPESIALIS
PELAYANAN TELEMEDICINE**

No	Poli	Nama DPJP
1	Penyakit Dalam	
2	Jantung	
3	Obgyn	
4	Paru	
5	Anak	

Lampiran IV Perjanjian

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor :

KETENTUAN RESPON KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK wajib melaksanakan program tanggap insiden apabila terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya, meliputi:

- a. respon keluhan subjek data pribadi,
- b. investigasi/analisis root cause insiden,
- c. pengambilan tindakan perbaikan sistem informasi yang terdampak,
- d. mitigasi dampak risiko, dan
- e. pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan koordinasi bersama, memfasilitasi pemenuhan hak-hak subjek data pribadi, pertanyaan, keluhan terkait pemrosesan data pribadi dan pelaporan kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dilakukan melalui narahubung masing-masing sebagai berikut:

- **PIHAK KESATU:**

Nama : Bagian IT Wilayah Jatim
Email : deputi.wil7@bpjs-kesehatan.go.id
No. HP : (031) 8432541

- **PIHAK KEDUA:**

Nama : Galih Satria Mahardika
Jabatan : Kepala Ruang IT
Email : itrsphsukorejo@gmail.com
No. HP : 083848055073

Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Pelindungan Data Pribadi, maka **PARA PIHAK** saling memberitahukan perubahan tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara. **PARA PIHAK** sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.

Lampiran V Perjanjian

Nomor : 83/KTR/VII-06/0525

Nomor :

**PAKTA INTEGRITAS
PENGUNAAN CONS-ID BRIDGING BPJS KESEHATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIK/Paspor :
Jabatan :
Email :
Nama Intansi :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya dalam menggunakan *cons-id*, *secret key*, dan *user key* dalam rangka *bridging* SIM dengan BPJS Kesehatan, akan menjaga kerahasiaannya dan tidak memiliki niat dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
2. Saya telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini. Demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara hukum apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini saya tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Januari 20....
Yang Menandatangani

Meterai
Rp 10000
(Nama Lengkap)